PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN · DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

# Organizar la respuesta intersectorial a las necesidades sociales complejas y coocurrentes en atención primaria

## Configuración de las redes adaptadas a los distintos perfiles de pacientes atendidos




**Eric Bernier**, LL.M. y M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
Doctorado en salud pública · Sistemas, organizaciones y políticas de salud · ESPUM, Université de Montréal

CODIRIGIDO POR LAS
**Dras. Nadia Sourial y Géraldine Layani**


## 01 Contexto

**Atención primaria en Canadá: 1 de cada 2 pacientes declara una necesidad social** · *Kosowan et al., 2025*

**19 %**
de hogares quebequenses con inseguridad alimentaria en 2023 (14 % en 2018)
*ISQ, 2026*

**40 %**
de hogares que gastan la mitad de sus ingresos en vivienda: techo o comida
*ISQ, 2026*

TRES NOCIONES A DISTINGUIR

***La coocurrencia se cuenta; la complejidad se describe; la respuesta intersectorial se organiza en un territorio.***

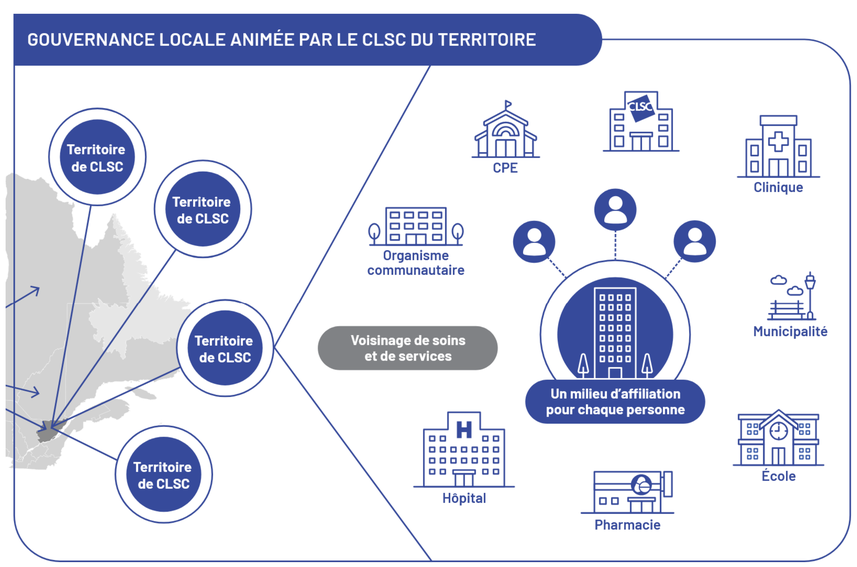
CRITERIO DE INCLUSIÓN
**Coocurrencia**
Al menos dos necesidades sociales a la vez.
*Kreuter et al., 2021*

DESCRITA, NO EXIGIDA
**Complejidad**
Acumulación de enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de salud mental y vulnerabilidad social.
*Kuluski et al., 2017*

SE ORGANIZA EN UN TERRITORIO
**Respuesta intersectorial**
Acciones de sectores distintos de la salud, realizadas con ella, sobre la salud o sus determinantes: CLSC, hospital, GMF, farmacias, organismos comunitarios, municipio, escuelas, CPE, privado.
*MSSS, 2017; Leppo et al., 2013*

POLÍTICA DE PRIMERA LÍNEA · MSSS, 2026

**El territorio de CLSC: nueva unidad de referencia**




CUATRO ROLES DEL CLSC

Navegador · Coordinador · Líder intersectorial · Cofacilitador

*«con un espíritu de gobernanza compartida» · MSSS, 2026, p. 42 · esquema: MSSS, 2026*

EJEMPLO FICTICIO · HILO CONDUCTOR

**MP Sra. Protocolo** · 58 años
*¿Quién responde? ¿Con quién? ¿Quién coordina?*

Aviso de desalojo → Inseguridad alimentaria → Deudas → Depresión (contexto clínico)

EL VACÍO

**El CLSC debe coordinar.** Pero, para una combinación de necesidades, nada indica qué socios movilizar, cómo vincularlos ni quién coordina. **Se conoce la programación, no las redes realmente constituidas en torno a las trayectorias.**

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

**¿Cómo se organiza la respuesta intersectorial para los distintos perfiles de pacientes con necesidades sociales complejas y coocurrentes atendidos en atención primaria?**

Meta: vincular cada perfil a… un perfil de necesidades → una configuración de socios → y su coordinador

## 02 Métodos

Ámbito: 3 territorios de CLSC contrastados en Lanaudière (privación material del 7 % al 50 % según la MRC), región pionera en intersectorialidad (mesa intersectorial) · diseño en varias fases · O2: SNA mixto secuencial explicativo, desplegado desde el CLSC

### ¿Qué perfiles?

O1 · IDENTIFICAR
**Revisión de alcance**
4 a 6 viñetas, validadas por 6 a 8 actores

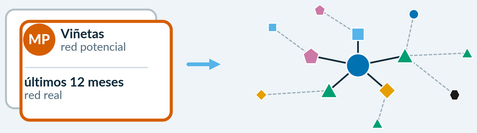
Estudios publicados → Perfiles recurrentes → Viñetas

→ perfiles convertidos en viñetas

MP *Su perfil se identifica en los estudios*

### ¿Quién moviliza a quién?

O2 · ANALIZAR
**Cartografía desde el CLSC**
3 CLSC y luego los contactos que nombran




→ redes potenciales y reales

MP *Pasa a ser una viñeta*

### ¿Por qué y cómo?

O2 · ANALIZAR
**SNA cualitativo**
15–25 entrevistas · 2–3 trayectorias reales por perfil




→ explicación de las interacciones

MP *Se explica su trayectoria real*

### ¿Qué recomendar?

O3 · RECOMENDAR
**Taller deliberativo**
15–20 participantes, con pacientes colaboradores



Pacientes colaboradores · Atención primaria · Comunitario · Gobernanza local · Municipal, privado

→ recomendaciones por perfil

MP *Su caso se delibera en el taller*

### Integrar

32 meses · 2026 → 2029
**Tabla conjunta por perfil**

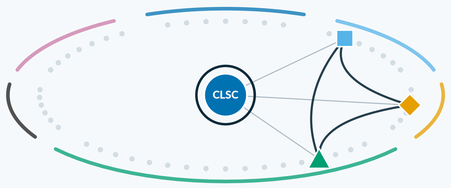
| Perfil | Red | Por qué | Rec. |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |

MP *Pautas para su perfil*

## 03 Resultados esperados

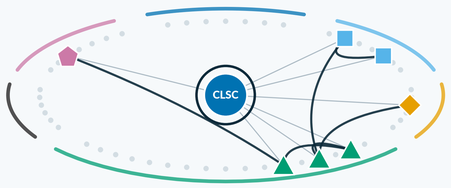
*Ejemplos ficticios* · **en cada CLSC, la red egocentrada cambia según el perfil**

**A** Predominio: vivienda
aviso de desalojo



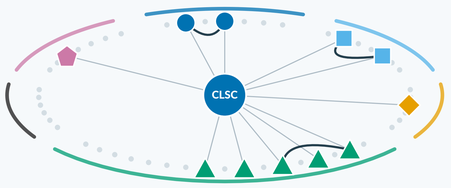

**3** socios, todos vinculados · el CLSC coordina

**B** Sra. Protocolo
vivienda · comida · deudas




**7** socios, aún vinculados · el CLSC coordina

**C** Acumulación + depresión
mismas necesidades, más depresión




**11** socios, poco vinculados · sin coordinador

CLSC (ego) · coordinador designado · vínculo declarado por los socios · organización no movilizada
Salud y servicios sociales · Primera línea, farmacias · Comunitario · Municipal · Educación, primera infancia · Empleo, justicia, privado

H1 **Los sectores cambian** según el perfil → *composición por sector*
H2 **Un núcleo común,** una periferia propia → *socios comunes*
H3 **Más socios,** pero menos vinculados → *tamaño y densidad*
H4 **¿El CLSC navega** y coordina? → *coordinador designado*
H5 **¿Cambia el género** la respuesta? → *versiones mujer, hombre*
≠ **Real o potencial:** ¿qué brecha? → *viñetas vs 12 meses*

## 04 Impactos y repercusiones

**No una «red ideal» universal: pautas para cada perfil.**

**Para las personas**
Una respuesta ajustada a su combinación de necesidades

**Para el CLSC y sus socios**
Pautas: a quién movilizar, cómo vincularse, quién coordina

**Para la política de primera línea**
Una línea de base; recomendaciones según los cuatro roles del CLSC

**Para la investigación**
Una hipótesis perfil–red; la brecha entre redes potenciales y reales

**Difusión:** devolución a los 3 territorios · protocolo publicado (OSF) · artículos

Todas las versiones: FR · EN · ES · 中文 · العربية · עברית · Innu · daltonismo · baja visión · Lectura fácil · audio
Sus ideas: comentarios · lecturas · contactos
Mi trayectoria: erjb-web.github.io


Referencias: CISSS de Lanaudière, 2024 · Creswell y Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · ISQ, 2026 · Kosowan et al., 2025, BMJ Open · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017; 2026, política de atención y servicios de primera línea · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016


· Colour-blind version: Okabe-Ito colours and one shape per sector